Sangrado de encías y mal aliento

Por qué ocurre, qué significa y qué hacer antes de que avance

¿Por qué se produce el mal aliento?

Cada vez que consumes azúcar, no solo te alimentas tú: también alimentas a las bacterias que viven naturalmente en tu boca. Esas bacterias usan el azúcar para producir energía, y al hacerlo liberan ácido como residuo. Ese ácido daña el esmalte y, junto con la acumulación de bacterias, forma un hábitat llamado **placa bacteriana** sobre los dientes y bajo el borde de la encía.

La placa bacteriana no controlada inflama la encía (gingivitis) y es también la principal fuente del mal aliento (halitosis): las bacterias que se acumulan en la placa, entre los dientes y sobre la lengua liberan compuestos sulfurados volátiles como subproducto de su actividad metabólica — son esos compuestos los responsables directos del olor. Por eso el mal aliento persistente casi nunca es un problema aislado: es la señal visible de que hay placa bacteriana acumulada y, muchas veces, encías inflamadas.

El sangrado al cepillarte es la encía avisando que está inflamada. No es un signo de que te cepillas "demasiado fuerte" ni algo que deba ignorarse: es el primer síntoma clínico de gingivitis.

Las consecuencias no siempre son las que crees

El daño más inmediato del mal aliento casi nunca es clínico — es social. La mayoría de las personas no te van a decir directamente que tienes mal aliento: ni un colega, ni una cita, ni siquiera un familiar cercano suelen hacerlo, porque es un tema incómodo de mencionar. Pero eso no significa que no lo noten.

Lo que ocurre en la práctica es más sutil y, muchas veces, más costoso: la persona simplemente te trata distinto. Mantiene más distancia física al hablar, acorta la conversación, evita acercarse. Ese cambio de comportamiento rara vez se explica — y muchas veces ni siquiera se llega a asociar conscientemente con el aliento. El resultado es que el problema se sostiene en silencio, sin retroalimentación directa que permita corregirlo a tiempo.

Por eso esta guía no empieza por el diagnóstico clínico, sino por el impacto real que tiene: no se trata solo de una encía inflamada, se trata de cómo te relacionas con las personas todos los días.

Autoevaluación rápida

Marca mentalmente cuáles de estas señales tienes hoy. Mientras más marques, más urgente es que actúes esta semana:

Señal	¿Te pasa?
Sangran las encías al cepillarte o usar hilo dental	Sí / No

Notas mal aliento persistente, incluso después de cepillarte	Sí / No
Encías rojas, hinchadas o sensibles al tacto	Sí / No
Sientes sabor metálico o desagradable de forma habitual	Sí / No
Algún diente se siente más largo, flojo o cambió de posición	Sí / No

Si marcaste 2 o más, no esperes — pasa directo a la sección "Qué hacer" y agenda una evaluación.

Qué hacer: los 3 hábitos que revierten la gingivitis a tiempo

La buena noticia: en su etapa inicial (gingivitis), la inflamación de la encía es reversible. No requiere tratamiento complejo — requiere consistencia en tres hábitos simples:

1. Cepillado con técnica correcta, con cepillo de cerdas suaves, dos veces al día (mínimo 2 minutos), sin presionar en exceso — presionar fuerte no limpia mejor, solo lesiona la encía.

2. Hilo dental una vez al día — el cepillo no llega al espacio entre los dientes, que es donde más se acumula la placa que causa el sangrado.

3. Pasta dental con la concentración de flúor correspondiente a la edad (ver tabla) — el flúor fortalece el esmalte frente al ácido que producen las bacterias.

Esquema de flúor recomendado según edad

Edad	Concentración	Cantidad por cepillado
Desde la erupción del primer diente hasta los 3 años	1.000 ppm	Una mancha o grano de arroz
3 a 6 años	1.000 ppm	Tamaño de una arveja
Desde los 6 años y adultos	1.450 ppm	Tamaño de una arveja (cubriendo el cepillo)

En menores de 3 años, supervisa siempre el cepillado para evitar que traguen pasta en exceso (riesgo de fluorosis si se ingiere de forma repetida y en grandes cantidades).

Regla práctica de autoevaluación: si mejoras estos 3 hábitos y evalúas en 1 semana, la mucosa de la encía debería empezar a regenerarse y el sangrado debería disminuir. Si no mejora en ese plazo, no sigas esperando — consulta con un odontólogo.

Si no se trata: la historia natural de la enfermedad

El sangrado de encías no es un punto final, es el inicio de un proceso progresivo. Así avanza, etapa por etapa, cuando no se interviene a tiempo:

Etapa 1 — Gingivitis (reversible)

La placa bacteriana inflama la encía. Sangra al cepillarte o usar hilo dental, puede verse enrojecida o hinchada. No hay daño al hueso todavía. Es 100% reversible con buena higiene.

Etapa 2 — Periodontitis inicial

Si la inflamación se mantiene sin tratarse, la infección avanza por debajo de la encía y empieza a comprometer el hueso que sostiene el diente. Ya no es solo un problema de la encía: hay pérdida de soporte, aunque aún puede no notarse a simple vista.

Etapa 3 — Periodontitis moderada a severa

La pérdida ósea avanza. Pueden aparecer espacios entre los dientes, retracción de la encía, sensibilidad marcada y, en algunos casos, mal aliento más intenso y persistente.

Etapa 4 — Movilidad y pérdida dentaria

Sin el soporte óseo suficiente, los dientes comienzan a moverse. En esta etapa, sin tratamiento, el desenlace es la pérdida de piezas dentarias — no por caries, sino por enfermedad de las encías no tratada a tiempo.

Tratamiento: qué sí y qué no reemplaza

Lo que sí hace una limpieza profesional (destartraje): remueve el sarro y la placa calcificada que el cepillado diario ya no puede eliminar por sí solo, y permite evaluar en qué etapa exacta está tu encía.

Lo que no reemplaza: ninguna limpieza profesional sustituye el hábito diario. Sin cepillado correcto e hilo dental en casa, la placa se vuelve a acumular en pocas semanas y el problema reaparece. El tratamiento profesional y el hábito diario funcionan juntos, no uno en lugar del otro.

Referencias

1. World Health Organization (WHO). Global Oral Health Status Report 2022: towards universal health coverage for oral health.
2. Ministerio de Salud de Chile (MINSAL). Resolución Exenta N.º 784: Norma técnica sobre uso de fluoruros en la prevención odontológica, 2015.
3. Ministerio de Salud de Chile (MINSAL). Encuesta Nacional de Salud (ENS) 2016-2017 — indicadores de salud bucal.
4. American Academy of Periodontology (AAP). Gum Disease Information — Gingivitis and Periodontitis.
5. European Federation of Periodontology (EFP). Perio & Me — patient information on gum disease.
6. American Dental Association (ADA). Statement on the Use of Fluoride-Containing Toothpaste for Young Children.
7. American Academy of Pediatric Dentistry (AAPD). Fluoride Therapy — Clinical Practice Guideline.
8. Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración (SEPA). Guía de salud de las encías para pacientes.

9. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Community Water Fluoridation — Guidance on Fluoride Use.
10. Chapple I.L.C. et al. Periodontal health and gingival diseases and conditions — clasificación EFP/AAP 2018, Journal of Clinical Periodontology.
11. National Institute of Dental and Craniofacial Research (NIDCR). Periodontal (Gum) Disease — Causes, Symptoms, and Treatments.

Esta guía tiene fines educativos generales y no reemplaza una evaluación clínica presencial. Cada caso es distinto: el diagnóstico y tratamiento correcto solo pueden determinarse con un examen realizado por un odontólogo.

¿Te sangran las encías o tienes mal aliento persistente?

Escríbeme directo por WhatsApp — esta semana tengo cupos de evaluación preferente.

wa.link/tu8qmu

Dr. Nicolás Guzmán — Odontología general · Concepción, Aníbal Pinto 295, Edificio Buró, Of. 303 · WhatsApp: wa.link/tu8qmu